

※老年护理

综合护理干预在老年痴呆患者中的应用效果

苏晓玲

摘要 目的 观察综合护理干预在老年痴呆患者中的应用效果。方法 将 40 例老年痴呆患者随机分为对照组和观察组,每组各 20 例,对照组予常规护理,治疗组实施综合护理干预。采用简易智能精神状态检查量表(MMSE)和日常生活能力量表(ADL)进行护理评估,及 Barthel 指数分级法评定 ADL 水平,比较 2 组患者的各量表得分。结果 干预后观察组 MMSE 分数与对照组比较,差异无统计学意义($P > 0.05$);观察组 ADL 分数与对照组比较有显著差异($P < 0.05$),观察组 ADL 水平与对照组比较有统计学意义($P < 0.05$)。结论 综合护理干预可提高老年痴呆患者的生活质量,在一定程度上可延缓病情的进展。

关键词: 老年性痴呆; 综合护理干预; 应用效果

中图分类号: R473.74

文献标识码: B

文章编号: 1006-6411(2012)03-0116-03

老年痴呆,又称阿尔茨海默病(AD),常发于 60 岁以上老年人,是以进行性认知功能障碍和行为损害为特征的中枢性退行性病变,临床多表现为记忆障碍、失语、失用、失认、视空间能力

损害、计算力下降、人格和行为改变^[1]。随着老龄化社会的到来,老年痴呆的患病率呈逐年上升趋势,目前老年痴呆位于老年人病死原因的第四位^[2],往往起病隐匿、具体起病时间不确定、病程长、呈持续进行性,预后较差,病程多在 5~10 年,最后死于肺炎和泌尿系感染,严重影响了患者及家属的生活质量^[3]。为改善老年痴呆患者的生活质量,减轻家庭及社会负担,笔者所在

工作单位:422200 邵阳 湖南省隆回县人民医院神经内科

收稿日期:2011-08-12

2.3 2 组患者满意度比较

实验组患者对护士的满意度为 97.5%,明显高于对照组患者对护士的满意度 85.2%,且差异有统计学意义, $\chi^2 = 15.22, P < 0.01$ 。

2.4 2 组患者血压控制效果比较(见表 3)

护理干预前,2 组患者血压控制效果无明显差异,实施护理干预后,实验组的血压控制效果比对照组好,差异有统计学意义($P < 0.05$),说明护理干预可以有效提高高血压的控制效果。

表 3 2 组患者血压控制效果比较 例

组别	例数	干预前		干预后	
		良好	欠佳	良好	欠佳
实验组	84	58	26	77 ^a	7 ^a
对照组	84	56	28	58	26

注: a 与对照组比较, $P < 0.05$

3 讨论

3.1 社区卫生服务是城市卫生工作的重要组成部分,也是人人享有初级卫生保健目标的基本环节。在我国老龄人口迅速增长,疾病谱转变,社区护理服务需求也日益增长,作为社区卫生服务团队重要成员的社区护士,需要承担起越来越多的责任和义务,要及时转变服务观念和服务模式。国务院十部委在 1997 年发表的《关于发展城市社区卫生服务的若干意见》中明确指出:社区卫生服务融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体,这预防就包括了慢性病的控制。目前,社区最常见的慢性病是高血压、糖尿病、冠心病、慢性阻塞性肺病、恶性肿瘤等。

3.2 高血压是一种以动脉血压持续升高为主要表现的慢性疾病,常引起心、脑、肾等重要器官的病变并出现相应的后果。同时,血压升高还是多种疾病的导火索,会使冠心病、心力衰竭及肾脏疾患等疾病的发病风险增高。随着我国经济的发展,人民生活水平日益提高,特别是居民饮食结构和生活方式的改变,我国高血压的发病人群呈现低龄化,患病率呈现明显上升趋势。中国高血压防治指南指出,除遗传因素外,高血压发病的危险因素有超重、烟酒和高钠 3 个,吸烟、精神紧张、动物油脂摄入过多也与高血压的发生密切相关,高血压一旦确诊,通常需要终生治疗(包括非药物治疗),这些治疗大多数时间需要在社区和家庭进行,因此社区护理干预有着十分重要的意义。本研究中,社区护理人员针对实验组高血压患者个人情况,从心理护理、健康教育、生活方式、药物和血压监测等方面给予护理干预,结果显示,对社区高血压患者实施护理干预,能提高患者的满意度,提高患者对高血压知识的知晓率,改善患者的遵医行为,从而将血压控制在理想水平,对高血压的防治起着十分重要的作用。

参 考 文 献

- 1 陆再英,钟南山. 内科学 [M]. 第 7 版. 北京: 人民卫生出版社, 2008: 251.
- 2 毕平. 我国老年人社区护理的现状与展望 [J]. 中国老年保健医学, 2008, 6(1): 71~72.
- 3 巩玉秀. 社区护理学 [M]. 第 1 版. 北京: 人民卫生出版社, 2008: 179.

(本文编辑: 邹 键)

科室对老年痴呆患者实施综合护理干预,取得了一定疗效,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择本院 2008 年~2011 年 6 月在神经内科住院的老年痴呆患者 40 例,所有患者均符合 CCMD—III—R^[1] 关于老年痴呆的诊断标准,均无严重疾病。将 40 例患者随机分为对照组和观察组,每组各 20 例,其中对照组男 9 例,女 11 例,年龄 62~75 岁,平均(68±5.8)岁,病程(2±1.7)年,文化程度为小学 7 例,中学 10 例,大学 3 例;观察组男 10 例,女 10 例,年龄 64~74 岁,平均(68±6.1)岁,病程(2±1.5)年,文化程度为小学 9 例,中学 9 例,大学 2 例。2 组在性别、年龄、病程、文化程度等一般资料上差异无统计学意义($P>0.05$),具有可比性。

1.2 方法

2 组患者均住院治疗 14 d,对照组予常规护理,观察组安排专人实施综合护理干预,具体如下:

1.2.1 心理护理 鼓励家属多陪伴患者,加强与患者的交流,可一起参加社会或家庭活动。尊重患者,以诚恳的态度对待患者,鼓励患者战胜疾病,以增强患者信心。针对患者不同病情,有计划地与患者交谈,消除患者的顾虑,培养乐观情绪,使患者以较好的心理状态配合治疗。

1.2.2 情感护理 针对患者焦虑情绪,在护理时应保持病房环境的舒适性,在适当的时间放一些轻松愉悦的音乐;针对患者抑郁倾述,应耐心倾听患者的倾述,不强迫患者做不愿意的事,以鼓励为主,引导患者进行适当的运动,如散步等;针对易激动情绪,应积极分析原因,安慰患者,避免语言刺激,鼓励患者做锻炼,以放松心情;针对淡漠情绪,可增加病房内物品摆放,比如患者感兴趣的物品,鼓励患者加强与他人的交流。

1.2.3 认知护理 对记忆的训练:念一串数字,让患者复述,逐渐增加难度,增强患者的瞬时记忆;让患者看数件物品后数分钟,让患者回忆刚刚所看到的物品,以增强短时记忆。对定向力的训练:开始让患者记忆一些特别的日期、时间等,如生日、节日,让患者尝试记忆亲人、护士、医生的姓名;对回忆的训练:让患者看对其意义较大的物品,使患者回忆往事;对分析能力的训练:让患者对物品进行分类;对口语的训练:给患者讲述一段故事,让患者回答一些简单的问题,或者简单概括故事的情节。

1.2.4 生活护理 给予患者自我照顾的机会,对患者进行生活能力训练,如洗漱、穿脱衣、进餐等,鼓励患者尽量自理,如完全不能自理,设专人护理,注意翻身拍背,按摩等,防止褥疮、感染

等并发症。对药物的发放,应按时按顿,指导患者将药物全部服下,对有幻觉的患者,应耐心劝说,详细解释。患者认知障碍严重时,常出现白天休息,夜间吵闹,应保持夜间病房安静,入睡后可予温水泡脚,对伴有严重睡眠障碍者,应给予药物帮助入睡。

1.2.5 安全护理 增强病房的安全性和舒适性,对有空间、时间定向力障碍的患者,要求有专人陪护,防止走失。对有行动不便的患者,增加相应的设施,如座便器、扶手等。

1.2.6 出院健康指导 老年痴呆尚无有效的治疗,以预防为主,关键是早发现、早治疗,延缓大脑细胞更加广泛和不可逆转的退变,以控制病情的进展,防止并发症的发生,延长生命,提高生活质量。护理人员对患者和家属进行相关知识培训,提高主动性,调动积极性,共同完成护理计划。鼓励患者家属出院后多陪伴患者,如散步、聊天,或参加一些学习和力所能及的社会家庭活动。给予多方面的帮助,使其消除孤独寂寞感,感受家庭的温馨和生活的快乐。嘱家属保持联系,指导家属参与家庭护理,定时电话或者上门指导患者家属护理的技巧和质疑事项。

1.3 评价指标

由 2 名经过一致性培训的护士,分别于护理干预前及护理干预 6 个月后进行评估。简易智力量表(MMSE)^[2]一共有 30 个问题,主要评定患者对时间地点的定向力、记忆力、注意力、计算力,以及语言复述、阅读理解等方面能力。答对得 1 分,答错得 0 分,总范围为 0~30 分。MMSE 评价痴呆的严重程度,分数越高,智能越好;日常生活功能水平量表(ADL)^[3]评价有否社会或行为能力,共 14 项,内容包括定时上厕所、行走、洗澡、穿衣、梳头、刷牙、进食、做家务、服药、打电话等。评分为 4 级,以总分 20 分为正常,总分大于 20 分即有不同程度功能下降。用 Barthel 指数分级法评定 ADL 水平,将 ADL 分为 3 级:大于 60 分为良,日常生活基本能够自理;60~41 分为中,有功能障碍、稍依赖;小于 40 分为差,依赖较明显或完全依赖。分别在干预前及干预 6 个月后进行评价。

1.4 统计学方法

用 SPSS16.0 软件进行统计学分析,计数资料以率表示,组间比较采用 χ^2 检验;计量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示,采用 t 检验, $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2 组 MMSE 和 ADL 量表得分比较

2 组量表得分:护理前比较无统计学意义($P>0.05$),护理后 2 组 MMSE 得分均有升高,但无统计学意义($P>0.05$);护理后观察组 ADL 分数明显高于对照组($P<0.01$),见表 1。

表 1 2 组相关量表得分比较 ($\bar{x} \pm s$,分)

组别	例数	MMSE		ADL	
		护理前	6 个月后	护理前	6 个月后
对照组	20	18.56±3.67	19.33±4.15	23.60±3.30	22.20±2.90
观察组	20	18.36±3.19	19.58±4.20	23.80±3.60	20.80±2.40
t		1.37	1.30	1.23	4.58
P		0.509	0.195	0.378	0.002

2.2 2 组 ADL 水平比较

2 组 ADL 水平都有不同程度提高,对照组良 1 例,中 10 例,

差 9 例;观察组良 3 例,中 12 例,差 5 例。2 组比较 $\chi^2=4.455$, $P=0.035<0.05$,差异有统计学意义,见表 2。

※基础护理

可调节封闭式负压引流技术在Ⅲ、Ⅳ期压疮中的应用体会及护理

林雪蓉

摘要 总结了可调节封闭式负压引流技术在Ⅲ、Ⅳ期压疮中的应用体会及护理。主要包括心理护理、用物准备、病室环境准备、基础护理、引流管的护理等。认为可调节封闭式引流技术治疗Ⅲ、Ⅳ期压疮能促进创面坏死组织引流,刺激创面肉芽生长,促进创面愈合,因此术后严密观察和护理是保证负压治疗成功的关键。

关键词: 封闭式负压引流技术; 压疮; 护理

中图分类号: R471

文献标识码: B

文章编号: 1006-6411(2012)03-0118-02

压疮是临床常见的并发症之一,患者多因病情危重,长期卧床,且存在不同程度的小便失禁、肢体瘫痪、营养失调及代谢障碍等,一直是护理中的难题。本科于2008年6月~2011年9月运用可调节封闭式负压引流技术对38例Ⅲ、Ⅳ期压疮患者进行治疗,护理上予以配合,取得很好效果,现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 本组38例,男26例,女12例;年龄48~82岁,平均年龄66岁;创面面积5 cm×4 cm~9 cm×7 cm,创面深度2~8 cm;病程最长者2年,最短者41d;其中21例压疮部位在骶尾部,12例压疮部位在股骨大转子,5例压疮部

位在髂嵴。

1.2 材料 ①负压治疗仪或者床旁中心负压系统;②氯己定缓释纱布、医用无菌薄海绵;③多侧孔硬质硅胶引流管;④3L粘贴手术巾。

1.3 方法 ①在手术室清除压疮创面的坏死组织。②创面基底敷以氯己定缓释纱布。③按创面大小和形状修剪医用无菌薄海绵,用1~3层薄海绵覆盖于氯己定缓释纱布之上。④在最外层海绵下放一多侧孔硬质硅胶引流管。以75%医用酒精擦洗创面周围皮肤,去除污物与油脂,干纱布擦干;以3L粘贴手术巾封闭创面。⑤将引流管接通负压治疗仪或者床旁中心负压系统,持续吸引,每4~5d更换1次材料,根据创面肉芽组织生长情况决定是否再次用该技术处理创面,并根据创面的大小使封闭创面内的负压保持在0.02~0.04MPa之间。⑥保持创面清洁、新鲜肉芽组织生长丰富后,根据创面大小与部位选择Ⅱ期缝

工作单位:618000 德阳 四川省德阳市人民医院

收稿日期:2011-10-30

表2 2组ADL水平比较 例(%)

组别	例数	良	中	差
对照组	20	1(5.0)	10(50.0)	9(45.0)
观察组	20	3(15.0)	12(60.0)	5(25.0)

注: $P < 0.05$

3 讨论

3.1 老年痴呆是老年期常见的一组慢性进行性精神衰退性疾病,在老年人的疾病和死亡谱中占有重要的位置。目前认为,老年期痴呆是由于慢性或进行性大脑结构的器质性损害引起的高级大脑功能障碍的一组症候群,是患者在意识清醒的状态下出现的持久的、全面的智能减退,是一种慢性精神致残及致死性疾病,我国估计在21世纪,65岁及以上的老年人中每年大约有数十万新发老年痴呆^[1]。

3.2 目前临床上虽然应用了一些药物,但目前仍没有确定的能有效逆转认知障碍的药物,而认知功能障碍是老年性痴呆的核心症状,故护理和非药物治疗对痴呆患者更为重要。笔者对老年痴呆患者实施综合护理干预,结果可知护理后MMSE得分与对照组比较差异无统计学意义($P > 0.05$),但比护理前分数提

高,这与国内报道一致^[2];观察组ADL分数明显高于对照组($P < 0.01$);观察组护理后ADL水平与对照组比较差异有统计学意义($P < 0.05$)。提示老年痴呆患者经过综合护理干预可提高患者生活能力,提高ADL水平,可有效改善患者生活质量,一定程度上能延缓痴呆的进展。

参 考 文 献

- 贾建平. 神经病学 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2008: 214.
- 盛树立. 老年性痴呆 [M]. 北京: 科学技术文献出版社, 1995: 5.
- 李浩, 高普. 实用老年疾病诊断与治疗 [M]. 北京: 科学技术文献出版社, 2000: 659.
- 中华医学精神科分会. 中国精神障碍分类与诊断标准 [M]. 济南: 山东科技出版社, 2001: 312~313.
- 曾大平, 赵美荣. 老年期痴呆的护理现状 [J]. 天津护理, 2002, 10(3): 153~155.
- 卢少萍, 符霞, 徐永能, 等. 早中期老年性痴呆病人的家庭健康指导 [J]. 中华护理杂志. 2005, 40(6): 403~405.

(本文编辑: 邹 键)